

Số: 564 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**THÔNG TIN THUỐC MỚI**  
**Thuốc điều trị Đái Tháo Đường HASANBEST 500/2.5**

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc HASANBEST 500/2.5. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

**1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc**

- Thành phần: Mỗi viên nén chứa hai hoạt chất chính là Metformin hydroclorid 500 mg và Glibenclamid 2.5 mg, cùng các tá dược khác.
- Cơ chế tác dụng: Sự kết hợp của hai nhóm thuốc hạ đường huyết với cơ chế bổ sung cho nhau:
  - o Metformin hydroclorid (nhóm biguanid): Giúp hạ đường huyết bằng cách giảm sản xuất glucose ở gan, tăng nhạy cảm với insulin ở cơ quan ngoại vi (giúp tăng sử dụng glucose ở tế bào) và làm chậm hấp thu glucose ở ruột. Metformin không kích thích tiết insulin
  - o Glibenclamid (nhóm sulfonyleure thế hệ hai): Giúp hạ đường huyết thông qua việc kích thích tế bào beta của đảo Langerhans ở tuyến tụy tăng tiết insulin.
- Dạng bào chế: Viên nén hình caplet, bao phim màu vàng cam, hai mặt lõm, cạnh và thành viên lành lặn.

**2. Chỉ định và liều dùng**

- **Chỉ định:** Điều trị đái tháo đường type 2 ở người lớn khi không kiểm soát được đường huyết bằng chế độ ăn uống, tập luyện đơn thuần và khi bệnh nhân phù hợp để sử dụng phác đồ phối hợp metformin với glibenclamid
- **Liều dùng:** Liều lượng được điều chỉnh tùy theo mức đường huyết và HbA1c của từng bệnh nhân
  - o Người lớn: Liều khởi đầu thường là 1 viên/lần/ngày
  - o Liều tối đa: 4 viên/ngày
  - o Cách dùng: Nên uống thuốc cùng với bữa ăn. Nếu dùng 1 viên/ngày thì uống vào buổi sáng; dùng 2 hoặc 4 viên/ngày thì chia làm 2 lần uống vào buổi sáng và buổi chiều



### 3. Các chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với metformin hydroclorid, glibenclamid, các sulfonyleurea hoặc sulfonamid khác, hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Nhiễm toan chuyển hóa cấp tính (bao gồm nhiễm toan lactic, nhiễm toan ceton do đái tháo đường) và tiền hôn mê đái tháo đường.
- Suy thận nặng (eGFR dưới 30 ml/phút/1,73m<sup>2</sup>) hoặc các tình trạng cấp tính có khả năng làm thay đổi chức năng thận (mất nước, nhiễm trùng nặng, sốc).
- Bệnh cấp tính hoặc mạn tính có thể gây thiếu oxy ở mô (như suy tim, suy hô hấp, nhồi máu cơ tim cấp, sốc).
- Suy gan, ngộ độc rượu cấp tính, hoặc nghiện rượu.
- Rối loạn chuyển hóa porphyrin.
- Dùng đồng thời với thuốc có chứa miconazol.
- Phụ nữ đang cho con bú.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

#### Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC  
BSCKI. NGUYỄN VĂN ĐỐI**